

Estado de México, a 02 de septiembre de 2025

Peso:66.900Kg Talla:156cm IMC (Peso /Talla 2) TA: 118/71mmHg.

Dr. Carlos Eduardo Penagos (listado)
PRESENTE

Paciente:
Fecha de última regla (FUM)

Solchaga Montiel María Dolores
28 de junio 2025.

Fecha probable de parto (USG actual)

05 de Abril de 2026

Se realizó estudio ultrasonográfico de alta definición, utilizando un equipo General Electric Voluson S-10 con transductor transvaginal, volumétrico de banda ancha, encontrando:

Impresión diagnóstica:

- Feto Vivo / Muerto En caso de Vivo Frecuencia Cardiaca Fetal de XXX latidos / minuto
- Embarazo de **13.4** semanas por longitud cráneo cauda (74.8 mm)
- Si algo sale positivo abajo, que salga aquí..}**

Comentario:

Antecedentes clínicos de importancia

- ☐ Edad materna: _____ años segun fechaa nacimiento
- ☐ IMC: _____ kg/m²
- ☐ Presion arterial media
- ☐ Ganancia de peso en el embarazo acgual
- ☐ Hipertensión crónica / Diabetes / LES / SAF: Sí / No
- ☐ Antecedente de preeclampsia / RCIU: Sí / No
- ☐ Embarazo múltiple: Sí / No
- ☐ Fertilización in vitro o donación ovular: Sí / No
- ☐ Presión arterial media (PAM): _____ mmHg
- ☐ Índice de pulsatilidad promedio de arterias uterinas (UtA-PI): _____ (p_____)
- ☐ Presencia de muesca bilateral: Sí / No
- ☐ Morfología placentaria: Normal / Lagunas / Engrosada / Irregular
- Antecedente de Parto Pretérmino (menos de 34 semanas) Sirve para el semaforo de parto pretrmino

- Exploración estructural: completa o incompleta.. y si es incompleta un espacio para detallar o poner el segmento anatómico**

- La exploración física no muestra otras alteraciones estructurales aparentes de las observables a esta edad gestacional. (esto que se active si en la

Sor Juana Ines de la Cruz No.280, San Lorenzo, CP 54033,
Tlalnepantla de Baz, Edo. Mex. Piso 6 Consultorio 601

Cto Centro Comercial 20, Cd. Satélite, CP 53100, Naucalpan de
Juárez, Edo. Mex., Consultorio Torre 2, Consultorio 629 y 630

exploración estructural no hay nada que resalte) Si Algo se resalta debe de agregarse en automático en el Impresión Diagnóstica

- **Tamizaje de cromosomopatías:**

La evaluación por edad y marcadores ultrasonográficos sitúa al feto en el grupo de **BAJA Probabilidad**, INTERMEDIA PROBABILIDAD O ALTA PROBABILIDAD diagnóstica.

- Riesgo Basal (Edad Materna) 1:XX Riesgo Ajustado (Edad Materna TN), FCF) (1:XX)

- **Muy alto:** TN ≥ 4.5 mm + DV anómalo $\pm$ hueso nasal ausente

En Caso de Que el Riesgo ajustado sea mayor de 1:100 de entrada queda el alta probabilidad diagnóstica y quede resaltado. ● **Alto:** TN ≥ 3.5 mm o ≥ 2 marcadores alterados

Si queda en menos de 1:1000 queda en riesgo bajo

Si queda en 1:100- 1:1000 es riesgo intermedio y poner requiere otros estudios

Evaluación global del riesgo (FMF algorithm)

- **Alto:** TN ≥ 3.5 mm o ≥ 2 marcadores alterados

- **Tamizaje de Preeclampsia Temprana (menos de 34)semanas**

La paciente presenta una **BAJA** probabilidad de presentar complicaciones placentarias temprana. (aquí solo hay opción baja y alta, en caso de alto riesgo la respuesta es se sugiere manejo preventivo)

- **Tamizaje de Enfermedades Placentarias tardías :**

La paciente presenta una **BAJA** probabilidad de presentar complicaciones placentarias tardías y restricción de crecimiento. (aquí queda alto y bajo riesgo) en caso de alto riesgo que salga, requiere seguimiento cercano del crecimiento fetal y conforme a la edad gestacional actual que cambie a las 28-30 semanas y que salga la fecha de acuerdo a la edad gestacional planteada en la impresión diagnóstica. Si sale en riesgo bajo: Se sugiere realizar curva de crecimiento fetal a las 35 semanas (que salga la fecha).

- **Tamizaje de Parto pretérmino:**

La paciente se encuentra en Riesgo bajo: Si LC mayor a 38mm e Índice de Consistencia Cervical (ICC) mayor o igual a 0.74.

La paciente se encuentra en Alto riesgo si cualquiera de los dos está positivo. En este caso se recomienda reforzar vigilancia con medición seriada y evaluación de factores materno adicionales

- **Líquido y Placenta:**
- **El líquido amniótico es normal/anormal,**

StarMedica Tlalnepantla

Sor Juana Ines de la Cruz No.280, San Lorenzo, CP 54033,
Tlalnepantla de Baz, Edo. Mex. Piso 6 Consultorio 601



Hospital San Angel Inn Satélite

Cto Centro Comercial 20, Cd. Satélite, CP 53100, Naucalpan de
Juárez, Edo. Mex., Consultorio Torre 2, Consultorio 629 y 630

- **La placenta es (anterior, posterior, lateral derecho – lateral izquierdo) de inserción (normal, baja temprana o previa temprana) se copie totalmente en la sección de placenta para no cagarla**

Dra. María Nallely Moreno Uribe

Especialista en Ginecología y obstetricia 7605178
Especialista en Medicina Materno Fetal C.P.8631423
Fetal Medicine Foundation No. 105171
Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia :7354
Consejo Mexicano de Medicina Materno Fetal:131

Dra. María Teresa Flores Molina

Especialista en Ginecología y Obstetricia
Especialista en Medicina Materno Fetal 14975747
Fetal Medicine Foundation No.275492
Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia : 13536
Consejo Mexicano de Medicina Materno Fetal: 589

Dra. Sandra Ivonne Pacheco Ruiz

Especialista en Ginecología y Obstetricia 14573228
Especialista en Medicina Materno Fetal C.P.14933179
Fetal Medicine Foundation No.215244
Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia : 14343

Exploración Estructural Feta

Completa

Incompleta

Adecuada / limitada

Pendiente

I (aquí que se ponga un tachecito como normal y salga la descripción de machote o anormal y solo el espacio para que el doctor detalle y entonces arriba en la impresión diagnóstica se corrija la parte de Evaluación estructural con un apartado que diga ver sección X Sistema nervioso central, cara, o algo así.. como vienen abajo y el doctor le ponga el diagnostico)

Sistema Nervioso Central . En el plano axial se identifican los hemisferios cerebrales con simetría adecuada, delimitados por la hoz interhemisférica y los plexos coroideos que ocupan gran parte de los ventrículos laterales, generando el clásico "signo de mariposa". El cráneo se observa íntegro, y osificado de manera homogénea. En el plano sagital medio, la

StarMedica Tlalnepantla

Sor Juana Ines de la Cruz No.280, San Lorenzo, CP 54033,
Tlalnepantla de Baz, Edo. Mex. Piso 6 Consultorio 601

Hospital San Angel Inn Satélite

Cto Centro Comercial 20, Cd. Satélite, CP 53100, Naucalpan de
Juárez, Edo. Mex., Consultorio Torre 2, Consultorio 629 y 630

translucencia intracraneal representa el cuarto ventrículo, visible entre el tronco encefálico y la cisterna magna, configurando junto con el "brainstem" el triple espacio anecoico característico del desarrollo normal de la fosa posterior. El tálamo y el diencefalo se delinearán de forma tenue, y aún no se distinguen estructuras corticales ni comisurales. La visualización de estas referencias confirma una neuroanatomía acorde a la edad gestacional y permite descartar alteraciones mayores tempranas del sistema nervioso central.

Macizo Facial En el corte sagital medio se evalúa la frente con una convexidad suave y continua de con la línea nasal que presenta una proyección ósea visible y proporciones armónicas con el tejido nasal blando. El hueso nasal mide X.X mm. El labio superior se visualiza como una línea ecogénica continua sin interrupciones ni hendiduras aparentes, y la mandíbula se proyecta adecuadamente hacia adelante, sin retrusión ni micrognatia. El macizo facial, nos permite identificar ambas órbitas simétricas y equidistantes. El tabique nasal se observa centrado y continuo, y el labio superior aparenta íntegro, evaluándose a través del triángulo retronasal

Cuello : El contorno cervical posterior se visualiza liso, no se observan colecciones quísticas. La Translucencia Nucal se midió en corte sagital medio verdadero siendo de X.XX mm

Torax Se observa de forma ovalada y bien delimitada por las costillas ecogénicas que rodean un parénquima pulmonar homogéneamente hipoecoico. El corazón ocupa aproximadamente un tercio del área torácica, con un situs (Solitus/ Inversus) y un (Levoapex / Dextroapex). En un corte de cuatro cámaras el ICT es de (0.45- 0.50 como valores normales), y el eje cardíaco es de (25 a 65 grados) normal. La frecuencia cardíaca fetal es de : XXX latidos minuto igual al que se refirió en el inicio del estudio

StarMedica Tlalnepantla

Sor Juana Ines de la Cruz No.280, San Lorenzo, CP 54033,
Tlalnepantla de Baz, Edo. Mex. Piso 6 Consultorio 601



Hospital San Angel Inn Satélite

Cto Centro Comercial 20, Cd. Satélite, CP 53100, Naucalpan de
Juárez, Edo. Mex., Consultorio Torre 2, Consultorio 629 y 630

 Abdomen fetal

La pared abdominal anterior se observa íntegra y continua en el plano de inserción del cordón. La unión cordón–pared muestra tres vasos (dos arterias, una vena) que convergen hacia el anillo umbilical. Todo el contenido intestinal se encuentra dentro de la cavidad abdominal. En el interior izquierdo se visualiza la cámara gástrica que se observa de dimensiones normales. Debajo de este corte, se identifican 2 siluetas renales. Las pelvículas renales aparentan normales, pues aún no existe un punto de corte específico. Se corroboran dos arterias renales con Doppler .

Columna: La columna cervical y dorsal se visualizan con alineación y curvatura fisiológica. Se identifican los centros de osificación vertebral en disposición lineal, continua y simétrica, desde la región cervical hasta el sacro. La piel que recubre el raquis es íntegra y continua, sin defectos ni protrusión de partes blandas. No se observan signos de disrafismo, cifosis o desviaciones laterales.

 Extremidades superiores e inferiores

Descripción anatómica:

Se identifican las cuatro extremidades con adecuada implantación, movilidad espontánea y simétrica. En miembros superiores se observan tres secciones en cada una de ellas (húmero radio, ulna y mano, fémur tibia peroné y pie). En este momento no es ideal la cuenta de dedos . Se visualizan movimientos de flexión y extensión

Líquido amniótico: Cualitativamente normal.

Placenta. (anterior, posterior, lateral derecho – lateral izquierdo) de incisión (normal, baja temprana o previa temprana)

: Corporal Anterior. Sin zonas de desprendimiento, de apariencia homogénea.

Longitud Cervical : De apariencia normal, longitud cervical (38mm). Índice de Consistencia Cervical 74%

Morfología Uterina : Normal / Tabique uterino anterior, posterior completo o incompleto.

StarMedica Tlalnepantla

Sor Juana Ines de la Cruz No.280, San Lorenzo, CP 54033,
Tlalnepantla de Baz, Edo. Mex. Piso 6 Consultorio 601



Hospital San Angel Inn Satélite

Cto Centro Comercial 20, Cd. Satélite, CP 53100, Naucalpan de
Juárez, Edo. Mex., Consultorio Torre 2, Consultorio 629 y 630

Miomas Visibles No visibles Clasificación FIGO de los Leiomiomas Uterinos (2021-2023)

Tipo FIGO	Localización anatómica	Descripción
0	Submucoso pediculado	Completamente intracavitario, unido al endometrio por un pedículo fino.
1	Submucoso con componente intramural <50%	Más del 50% del volumen protruye hacia la cavidad endometrial.
2	Submucoso con componente intramural ≥50%	Menos del 50% del volumen se proyecta dentro de la cavidad endometrial.
3	Intramural en contacto con el endometrio, sin distorsionar la cavidad	Lesión completamente intramural, pero adyacente al endometrio.
4	Intramural puro	Lesión completamente dentro del miometrio, sin contacto con endometrio ni serosa.
5	Subseroso con componente intramural ≥50%	Mayor parte del volumen dentro del miometrio, protruyendo hacia la serosa.
6	Subseroso con componente intramural <50%	Predomina el componente subseroso, con mínima extensión intramural.
7	Subseroso pediculado	Completamente extracavitario, unido a la serosa uterina mediante un pedículo.
8	Otros (parasitarios, cervicales, retroperitoneales, ligamento ancho)	Sin relación directa con la cavidad endometrial ni la serosa del cuerpo uterino.
Híbrido (2 números)	Miomas que afectan simultáneamente endometrio y serosa	Se describen con dos números que representan la extensión hacia ambas superficies (p. ej., tipo 2–5).

StarMedica Tlalnepantla

Sor Juana Ines de la Cruz No.280, San Lorenzo, CP 54033,
Tlalnepantla de Baz, Edo. Mex. Piso 6 Consultorio 601



Hospital San Angel Inn Satélite

Cto Centro Comercial 20, Cd. Satélite, CP 53100, Naucalpan de
Juárez, Edo. Mex., Consultorio Torre 2, Consultorio 629 y 630

Bibliografía

1. Munro MG, et al. FIGO Classification System (2021 update): Leiomyoma subclassification. Int J Gynaecol Obstet. 2022.
2. ISUOG Practice Guidelines. Ultrasound assessment of uterine leiomyomas. 2023.
3. Ducholm M, et al. UOG. 2021 – Imaging-based classification of fibroids.
4. Donnez J, Dolmans MM. N Engl J Med. 2016 – Uterine fibroids and reproductive outcomes.

Registro ecográfico Prenacer de miomas identificados

# Miom a	Tipo FIGO	Localizaci n uterina	Dimensio s (mm)	Relació n con cavidad / serosa	Vascularizació n (Doppler)	Observacion es clínicas
1	_____	_____	_____ × _____ × _____	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____ × _____ × _____	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____ × _____ × _____	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____ × _____ × _____	_____	_____	_____

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ceresfertilidad.com%2Fimpacto-de-los-miomas-en-la-fertilidad-humana%2F&psig=AOvVaw1CS0goRHEujJyGU_m5YZd&ust=1760657625336000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBIQjRxqFwoTCJinvfSup5ADFQAAAAAdAAAAABAE

Morfología uterina

Clasificación ESHRE–ESGE de malformaciones müllerianas (2021–2023)

Clasificación	Tipo específico / Subtipo	Descripción ecográfica resumida
☐ U0 – Útero normal	—	Cavidad y contorno uterino normales.
☐ U1 – Útero dismórfico	U1a (T-shaped) / U1b (infantil)	Cavidad estrecha o en forma de T o Y, fondo convexo.

StarMedica Tlalnepantla

Sor Juana Ines de la Cruz No.280, San Lorenzo, CP 54033,
Tlalnepantla de Baz, Edo. Mex. Piso 6 Consultorio 601



Hospital San Angel Inn Satélite

Cto Centro Comercial 20, Cd. Satélite, CP 53100, Naucalpan de
Juárez, Edo. Mex., Consultorio Torre 2, Consultorio 629 y 630

Clasificación	Tipo específico / Subtipo	Descripción ecográfica resumida
☐ U2 – Útero septado	U2a (septum parcial) / U2b (completo)	Fondo uterino externo normal, con tabique interno visible.
☐ U3 – Útero bicorne	U3a (parcial) / U3b (completo)	Fondo uterino hendido, cavidades separadas >50% del espesor miometrial.
☐ U4 – Útero hemiútero (unicornuado)	U4a (cuerno rudimentario funcional) / U4b (no funcional)	Cavidad única lateral, con o sin cuerno rudimentario.
☐ U5 – Útero aplásico o agénésico	—	Ausencia parcial o total de cuerpo y/o cérvix uterino.
☐ U6 – No clasificable / Combinado	—	Alteraciones mixtas o atípicas no incluidas en categorías previas.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ceresfertilidad.com%2Fimpacto-de-los-miomas-en-la-fertilidad-humana%2F&psig=AOvVaw1CS0goRHEujJyGU_m5YZd&ust=1760657625336000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBIQjRxqFwoTCJinvfSup5ADfQAAAAAdAAAAABAE

hecklist Prenacer – Marcadores ecográficos del primer trimestre (FMF 2025)

Marcador	Punto de corte de normalidad (FMF)	Resultado
Translucencia nuchal (mm)	< 95 percentil para EG (<2.5–2.8 mm aprox.)	Normal / Anormal
Hueso nasal	Presente (ausente = riesgo ↑)	Normal / Anormal
Ductus venoso	Onda A positiva (reversa o ausente = riesgo ↑)	Normal / Anormal
Regurgitación tricuspídea	Ausente (≥ 60 cm/s = riesgo ↑)	Normal / Anormal
Vejiga fetal	<7 mm de diámetro	Normal / Anormal
Cordón umbilical	3 vasos, inserción central	Normal / Anormal
Abdomen y pared abdominal	Cierre completo después de 12 sem	Normal / Anormal
UtA-PI promedio bilateral	< p95	Normal / Anormal
Morfología placentaria	Homogénea	Normal / Anormal

StarMedica Tlalnepantla

Sor Juana Ines de la Cruz No.280, San Lorenzo, CP 54033,
Tlalnepantla de Baz, Edo. Mex. Piso 6 Consultorio 601



Hospital San Angel Inn Satélite

Cto Centro Comercial 20, Cd. Satélite, CP 53100, Naucalpan de
Juárez, Edo. Mex., Consultorio Torre 2, Consultorio 629 y 630

Marcador	Punto de corte de normalidad (FMF)	Resultado
Longitud cervical (mm)	>25 mm	Normal / Anormal
Índice de consistencia cervical (%)	≥65 %	Normal / Anormal

Evaluación global del riesgo (FMF algorithm)

Bibliografía

1. Nicolaides KH. *FMF First Trimester Screening Protocol Update*. 2024–2025.
2. Poon LC, et al. *UOG*. 2022 – FMF algorithm for aneuploidy screening.
3. ISUOG Practice Guidelines. *Performance of first-trimester ultrasound*. 2023.
4. Maiz N, et al. *UOG*. 2017 – Ductus venoso y regurgitación tricuspídea.
5. Syngelaki A, et al. *Prenat Diagn*. 2020 – Doppler uterino temprano y riesgo placentario.

Nota de Responsabilidad Médico-Legal

Este estudio se realizó conforme a las **guías y protocolos de la Fetal Medicine Foundation (FMF 2024–2025)** y las **ISUOG Practice Guidelines (2023)** para la evaluación ecográfica del primer trimestre (11+0 a 13+6 semanas, LCC 45–84 mm). Su objetivo es **estimar el riesgo de aneuploidías, disfunción placentaria y parto pretérmino**, mediante la integración de hallazgos ecográficos (translucencia nuchal, hueso nasal, ductus venoso, regurgitación tricuspídea, ángulo facial y Doppler uterino), factores maternos y parámetros clínicos.

Este examen **no constituye un diagnóstico definitivo**, sino una herramienta de **tamizaje predictivo** que permite identificar pacientes con mayor probabilidad de desarrollar alteraciones cromosómicas o complicaciones placentarias.

Los resultados deben interpretarse dentro del contexto clínico global, considerando los antecedentes maternos, los marcadores bioquímicos (PAPP-A, β -hCG libre, PlGF, sFlt-1) y la evolución obstétrica.

La exactitud de las mediciones depende de la **posición fetal, calidad de la imagen, experiencia del operador y las condiciones maternas** (índice de masa corporal, pared

abdominal, actividad fetal).

Este estudio **no sustituye la vigilancia médica ni garantiza la ausencia futura de enfermedad**, malformaciones menores, alteraciones genéticas o metabólicas.

Ante resultados de riesgo intermedio o alto, se recomienda **asesoría genética y pruebas diagnósticas confirmatorias** (DNA fetal, amniocentesis o biopsia corial) según protocolo clínico.

En Prenacer, este estudio se realiza bajo estándares internacionales de calidad y certificación FMF, garantizando la mejor precisión técnica y ética profesional disponible.

StarMedica Tlalnepantla

Sor Juana Ines de la Cruz No.280, San Lorenzo, CP 54033,
Tlalnepantla de Baz, Edo. Mex. Piso 6 Consultorio 601



Hospital San Angel Inn Satélite

Cto Centro Comercial 20, Cd. Satélite, CP 53100, Naucalpan de
Juárez, Edo. Mex., Consultorio Torre 2, Consultorio 629 y 630